Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent10vfaz@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5186265-94.2022.8.21.0001/RS

AUTOR: SUZAN MERI GONCALVES DE OLIVEIRA

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por **SUZAN MERI GONCALVES DE OLIVEIRA** em face do **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL** visando ao fornecimento do medicamento **Ribociclibe 600mg/dia,** em razão de seu diagnóstico de neoplasia de mama com receptores hormonais positivos, metastática para ossos (CID10 C 50.9). Requereu, em antecipação de tutela, a concessão do fármaco e, no mérito, a procedência do pedido. Anexou documentos (evento 1, INIC1).

A 1ª Vara da Fazenda Pública declinou da competência para a 10ª Vara da Fazenda Pública (evento 4, DESPADEC1).

Concedidas a assistência judiciária gratuita e a medida liminar e determinada a produção de prova pericial antecipada (evento 7, DESPADEC1).

Anexada a perícia cuja conclusão foi pela ausência de documentação para análise adequada da doença e de sua terapia (evento 14, PERÍCIA1).

A parte autora anexou documentação médica e requereu a apresentação de novo laudo pericial (evento 17, PET1).

O demandado comunicou o cumprimento da decisão (evento 25, OFIC1).

Acostado laudo pericial complementar (evento 27, PERÍCIA1).

A parte autora requereu a procedência do pedido (evento 35, PET1).

O requerido manifestou ciência do laudo pericial complementar (evento 37, PET1).

Citado, o réu apresentou contestação, alegando, em síntese, que qualquer medicamento oncológico a ser disponibilizado pelo IPE Saúde depende de previsão normativa inequívoca, o que não acontece neste caso, já que as atuais Recomendações Técnicas em Oncologia não prevêem a cobertura para essa medicação, bem como que se mostra possível o fornecimento da medicação pelo medicamento genérico ou similar, a fim de que o cumprimento da decisão judicial ocorra da forma menos gravosa ao Instituto. Requereu a improcedência do pedido (evento 46, CONT1).

A parte autora apresentou réplica (evento 49, RÉPLICA1).

Intimadas sobre o interesse na produção de outras provas (evento 51, DESPADEC1), as partes informaram não haver interesse na produção de outras provas (evento 55, PET1 e evento 57, PET1).

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido (evento 61, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Passo a fundamentar.

A Constituição Federal, no *caput* do artigo 6º, assegurou o direito fundamental à saúde. No artigo 196, por sua vez, consagrou-a como direito de todos e dever do Estado, preceituando que:

> *Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*

Dito isso, observo que a negativa do IPE-Saúde em fornecer o tratamento postulado baseou-se na seguinte justificativa (evento 1, OUT5):

> Indeferimento da solicitacao 22/09/2022
> PARECER DESFAVORAVEL- O IPESAUDE NãO FORNECE COBER
> TURA PARA A MEDICAçAO SOLICITADA CONFORME "DIRE
> TRIZES DE COBERTURA DOS TRATAMENTOS ONCOLOGICOS" D
> ISPONíVEL NO SITE -> ACESSAR INSTRUçãO NORMATIVA D
> O IPE SAúDE Nº 02, DE 27 DE ABRIL DE 2021 (ATUALIZ
> ADA PELA INSTRUçãO NORMATIVA Nº 14, DE NOVEMBRO DE
> 2021).

Entretanto, verifico que os documentos coligidos aos autos evidenciam que a autora foi diagnosticada com neoplasia de mama com receptores hormonais positivos, metastática para ossos (CID10 C 50.9).

Nesse sentido, o atestado apresentado pelo médico que acompanha a parte autora esclareceu que (evento 1, LAUDO6):

A paciente Suzan Meri Gonçalves de Oliveira, CPF 675.684.400-87, apresenta diagnóstico de CÂNCER DE MAMA (CID C50). Atualmente apresenta doença metastática, com múltiplos sítios de acometimento ósseo.

Por necessitar iniciar tratamento com urgência, a fim de evitar a progressão da doença para outros órgãos e para tratamento de dor óssea, foi solicitado ao seu convênio tratamento com fulvestranto 500mg a cada 28 dias (contínuo) associado ao ribociclibe 600mg/d (D1 ao D21). O ribociclibe foi negado por sua operadora de saúde.

A adição de ribociclibe (Kisqali®) à hormonioterapia em primeira linha aumenta muito a chance de controle da doença, bem como praticamente duplica o tempo em que a doença fica sob controle. Esta medicação é aprovada pela ANVISA, descrita em bula médica e encontra-se em comercialização nacional. Anexo a este laudo, além da bula atualizada, segue cópia do estudo clínico de fase III, multicêntrico e internacional, randomizado, que comprova a eficácia da associação do ribociclibe ao fulvestranto nas pacientes pós-menopáusicas com câncer de mama avançado (https://doi.org/10.1200/JCO.2021.39.15_SUPPL.1001). Nesse estudo houve claro aumento em sobrevida global favorecendo o grupo de pacientes que recebeu a combinação (mediana não atingida versus 51,8 meses; HR, 0.64; 95% CI, 0.46-0.88).

Além disso, a associação de um inibidor CDK4/6 (ribociclibe) ao tratamento em conjunto com fulvestranto e/ou um inibidor de aromatase é o tratamento de primeira escolha de diversas sociedades e recomendada pelas sociedades americana e européia de oncologia clínica. Além disso, a alternativa a tal tratamento seria a quimioterapia endovenosa sistêmica - muito mais tóxica e com diversos efeitos adversos não justificáveis nesse momento.

A medicação ribociclibe (Kisqali®) apresenta ação para melhorar significativamente a qualidade de vida da paciente, a dor, o risco da progressão de sua doença bem como o risco de vida trazido pelas metástases múltiplas. Ela ainda comprovadamente aumenta o tempo em que a doença fica sob controle e, por consequência, o tempo de vida da paciente.

O uso se faz necessário e em caráter de URGÊNCIA. O atraso no início do tratamento poderá significar piora da qualidade de vida e oferecer risco de morte, por estar sem a terapêutica que oferece a maior chance de resposta e tem comprovada eficácia em sobrevida global.

Por tal razão recomento o início do tratamento com a medicação ribociclibe (Kisqali®), na dose de 600mg por dia (3 comprimidos de 200mg cada), via oral, tomados do dia 1° ao 21° de cada ciclo de 28 dias em conjunto com fulvestranto, em uso contínuo. A combinação deverá ser usada pelo tempo que se manter eficaz. A paciente passará por avaliações periódicas com imagens e exames que comprovem a manutenção da eficácia do tratamento.

A prescrição médica, por sua vez, é a seguinte (evento 1, RECEIT7):

RIBOCICLIBE (KISQALI)® 200mg..... USO CONTÍNUO (63 cp/mês)

Tomar 03 comprimidos, UMA vez ao dia, por 21 dias consecutivos.
Parar por 7 dias, e reiniciar protocolo.

*** deve ser utilizado em conjunto com fulvestranto 500mg, IM, a cada 28 dias.

Por tais razões, foi proferida decisão liminar com a seguinte deliberação (evento 7, DESPADEC1):

> *Ante o exposto,* ***DEFIRO, PROVISORIAMENTE, O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA*** *formulado e determino ao IPE-Saúde que, no prazo de 03 (três) dias úteis, passe a disponibilizar à parte autora o medicamento* ***RIBOCICLIBE 200MG****, nos termos da prescrição e laudo médico (Evento 1, RECEIT7 - 600MG/DIA), os quais deverão ser atualizados pela parte autora semestralmente.*

Ademais, o laudo pericial complementar acostado aos autos apresentou a seguinte conclusão (evento 27, PERÍCIA1):

> Sr. Juiz, diante dos documentos acostados nos autos (evento17) que comprovam o subtipo de doença da autora, o perito retifica a perícia anterior (evento14) e considera apropriado, adequado e indicado o emprego de ribociclibe 200mg – 03 comprimidos ao dia (600mg) por 21 dias seguidos com pausa de 07 dias e assim sucessivamente para tratamento da moléstia da autora.
> A terapia deve perdurar enquanto houver benefício clínico, ou seja, não ocorrer aumento (progressão de doença) ou surgir efeito colateral grave e de difícil manejo.
> Cordialmente e à disposição.

Assim, diante das alegações da parte autora, corroboradas pela documentação juntada aos autos - especialmente os laudos médicos, devidamente fundamentados na justificativa da indicação de tratamento -, está demonstrada a necessidade de uso dos fármacos.

Não obstante, é imprescindível considerar que o médico assistente é quem detém a melhor capacidade para indicar o medicamento com melhor eficácia para tratar a autora.

A assistência à saúde prestada pelo IPE-Saúde está submetida ao regime de direito público e deve seguir as regras definidas na Lei Complementar nº 15.145/2018 e nos atos normativos da autarquia estadual, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

Em 06.04.2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE-Saúde, revogando a Lei Complementar nº 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPE-Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais e medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º).

Destarte, comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento preconizado pelo médico assistente, não há razão para a negativa do IPE-Saúde, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade. Para tanto, seria necessário que o Instituto requerido expusesse de forma

clara e específica a justificativa técnica médica para o indeferimento do tratamento postulado.

Importante aduzir que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Logo, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se mostra minimamente razoável limitar as alternativas terapêuticas disponíveis para o seu tratamento às listadas em protocolo que historicamente não consegue acompanhar a velocidade dos avanços da medicina, o que, caso ocorresse, configuraria efetiva negativa de adequado tratamento à parte autora, expondo-a a risco de dano irreparável a sua saúde.

Ademais, descabida a alegação do demandado de que o fornecimento da prestação de saúde, por não estar prevista nas suas tabelas vigentes à época, implicaria sobrecarga, ou mesmo comprometimento do orçamento da autarquia destinado à saúde, visto que eventual negativa, nessas circunstâncias, só poderia ocorrer com base em contestação técnica médica suficiente.

Não há prova alguma no processo que evidencie qualquer impedimento ao cumprimento da determinação judicial pelo demandado. Outrossim, a autarquia não se desincumbiu de provar que o tratamento indicado pelo médico assistente acarretaria oneração desnecessária para o Instituto.

Com efeito, em que pese a medicação solicitada não constasse nas tabelas de cobertura da autarquia, não há que se falar em ilegalidade da pretensão da parte autora, tampouco em afronta aos princípios da isonomia e da igualdade. Neste sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPE-SAÚDE. CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE STENT DIVERSOR DE FLUXO PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE AUTORA, CREDENCIADA AO IPERGS. ASSISTÊNCIA MÉDICA. COBERTURA DO PLANO. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Caso em que o procedimento postulado não se inclui dentre os tratamentos não cobertos pelo IPERGS – arts. 41 e 42 da Resolução nº 21/79 –, portanto, não há falar em descabimento da pretensão da parte autora, tampouco afronta aos princípios da isonomia, igualdade e da legalidade. Portanto, falta amparo legal à recusa da autarquia previdenciária em custear o procedimento, materiais prescritos por médico vinculado ao Plano de Assistência Médica. (...) À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.(Apelação Cível, Nº 70079189999, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 12-12-2018).*

Dessa maneira, evidenciado o direito da parte autora - enquanto beneficiária - de postular ao IPE-Saúde, autarquia do Estado responsável pelo sistema de saúde, o fornecimento da medicação postulada, necessária ao tratamento de sua patologia.

Por conseguinte, levando em conta o conjunto probatório carreado aos autos, notadamente os laudos médicos atestando a imprescindibilidade do fornecimento dos fármacos requeridos, imperioso o acolhimento do pleito apresentado na inicial.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE o pedido** formulado por Suzan Meri Gonçalves de Oliveira em face do IPE-SAÚDE - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, tornando definitiva a decisão que deferiu a tutela antecipada (evento 7, DESPADEC1).

Ratifico a gratuidade da justiça à parte autora, já deferida anteriormente (evento 7, DESPADEC1), nos termos do artigo 98 do CPC.

Isento o demandado do pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei 14.634/14.

Condeno o IPE-Saúde ao pagamento das despesas processuais, nos termos do artigo 84 do CPC, bem como dos honorários advocatícios às procuradoras da parte autora, que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/20211, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Caso seja interposto recurso de apelação, processe-se conforme os trâmites legais e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Havendo saldo remanescente nos autos, expeça-se alvará em favor de quem for de direito.

Com o trânsito em julgado, proceda-se à baixa do presente feito.

Documento assinado eletronicamente por **GABRIELA DANTAS BOBSIN, Juíza de Direito**, em 16/6/2023, às 15:1:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10040350255v4** e o código CRC **1371232a**.